

NGUYỄN TẠC DINH DẪN VÀ TỔ CHỨC DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN

Pgs.Ts: Trần Thị Phúc Nguyệt
Đại Học Y Hà Nội

MỤC TIÊU

Sau khi học xong : học viên có khả năng

- Nêu được tầm quan trọng của ăn uống khi bị bệnh
- Thuộc các nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cơ bản
- Tổ chức nuôi dưỡng bệnh nhân trong bệnh viện

Hypocrat (460-377 TCN)

< Thức ăn cho người bệnh phải là phương tiện điều trị và các phương tiện điều trị của chúng ta phải là các chất dinh dưỡng >

Sidengai người kế thừa di chúc của Hypocrat:

<Để nhằm mục đích phòng bệnh cũng nh điều trị trong nhiều bệnh chỉ cần cho ăn những chế độ ăn thích hợp và sống một đời sống có tổ chức hợp lý>

Hải Thọng Lãn Ông (TK 18)

<Có thuốc mà không có ăn uống thì cũng đi đến chỗ chết>

Vai trò của dinh dưỡng điều trị:

1. Ăn điều trị có tác dụng trực tiếp tới nguyên nhân gây bệnh
2. Ăn điều trị làm tăng sức đề kháng chung của cơ thể
3. Ăn điều trị ảnh hưởng đến cơ chế điều hoà thần kinh thể dịch
4. Ăn điều trị có vai trò trong phục hồi cơ thể
5. Ăn điều trị có tác dụng phòng bệnh
6. Ăn điều trị có vai trò trong một số bệnh chuyển hoá

MỘT SỐ KHỐI NIỀM CỜ BÀN

Dinh dưỡng hỗ trợ dùng để chỉ cách nuôi dưỡng bệnh nhân qua đường miệng, ống thông và đường tĩnh mạch nhằm cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh có nguy cơ cao.

Nuôi dưỡng qua đường miệng là cách đa thức ăn thông thường qua đường miệng để đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng khác nhau cho bệnh nhân.

Nuôi dưỡng qua ống thông là cách nuôi dưỡng bổ sung hoặc thay thế nuôi ăn qua đường miệng khi lượng thức ăn ăn vào của bệnh nhân quá thấp.

Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch là sự cung cấp các chất dinh dưỡng theo nhu cầu cơ thể cho bệnh nhân nặng bằng đường tĩnh mạch. Có thể nuôi qua đường tĩnh mạch bổ sung hoặc thay thế hoàn toàn

CÁC NGUYÊN TẮC DINH DƯỠNG ẨM THỰC

1. NH GI TH TRNG DINH DNG CÁ NG I B NH

1.1. Tìm hiểu tiền sử dinh dưỡng

1.2. Phát hiện các triệu chứng thiếu dinh dưỡng đặc hiệu

1.3. Đánh giá TTDD bằng các chỉ tiêu nhân trắc

□ Người lớn:

$$\text{BMI (chỉ số khối cơ thể)} = \frac{\text{Cân nặng (Kg)}}{\text{Chiều cao}^2(\text{m})}$$

□ Đối với trẻ em

- SDD thể thiếu cân : $\text{CN} / \text{tuổi} < - 2 \text{ SD}$
- SDD thể thấp còi (SDD kéo dài): $\text{CC}/\text{tuổi} < - 2 \text{ SD}$
- SDD thể gầy còm (SDD cấp tính): $\text{CN}/\text{CC} < - 2 \text{ SD}$
- Thừa cân $\text{CN} / \text{CC} > + 2 \text{ SD}$

Trong lâm sàng chỉ số CN/CC là quan trọng hơn cả vì ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của bệnh

1.4. Đánh giá tình trạng dự trữ năng lượng của cơ thể

- Dự trữ Lipit: Đo Bề dày nếp gấp da. Nếu số đo đọc ở dưới mức 60 % đọc coi là giảm dự trữ Lipit
- Dự trữ protein nội tạng:
Đọc coi là thiếu DD khi:
Albumin huyết thanh $< 3,5$ g/dl

2. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĂN CHO BỆNH NHÂN

1. Khi đưa ra các chế độ ăn khác nhau phải đảm bảo sự cân đối, đầy đủ và toàn diện của nó, phù hợp với đặc tính biết thức của bệnh, chú trọng những bệnh đặc biệt.
2. Xác định thời hạn của chế độ ăn không cân đối, không toàn diện và không đầy đủ
3. Qui định những nguyên tắc ăn uống ở bệnh nhân tiến hành liệu pháp đặc biệt (liệu pháp sinh hoá, liệu pháp vật lí...)
4. Đề ra các nguyên tắc phối hợp giữa các yếu tố dinh dưỡng, điều trị với việc sử dụng kháng sinh và các phương tiện khác của liệu pháp thuốc
5. Qui định chế độ ăn phải phù hợp với hoạt động của bệnh nhân, chú ý tới việc đề phòng sự hạn chế hoạt động sau này do ảnh hưởng của ăn uống gây ra
6. Nguyên tắc lựa chọn thực phẩm
 - Hạn chế hoặc loại trừ các thức ăn thô, các thực phẩm khó tiêu
 - Thực phẩm xay nhỏ và nghiền nhừ
 - Chế biến tốt nhất là phương pháp hấp và nấu, hạn chế phương pháp rán

MỘT SỐ CHẤM ỖN ỖU TR

CHỈ ĐỊNH VÀ NGUYÊN TẮC

- Chỉ định: Những bệnh nhân mắc các bệnh thông thường, không cần kiêng cử gì đặc biệt.
- Nguyên tắc: Nhu cầu và tỷ lệ các chất dinh dưỡng gần với người bình thường

C [?] cấu khẩu ph [?] h	Gi [?] i h [?] h m [?] c ăn trung bình	
	T [?] i th [?] ọ	T [?] i ăa
T [?] ng năng l [?] ng (Kcal/ngà [?])	2000	2200
% NL t [?] Protein	12	15
% NL t [?] Lipid	15	25
% NL t [?] Glucid	55	75
Ch [?] tt x [?] d [?] ng polysaccharid	16 g/ngà [?]	24 g /ngà [?]
Mu [?] i ăa		6-10 g /ngà [?]
Rau c [?] c lo [?] i	200 g/ngà [?]	300-500 g /ngà [?]
Quả ch [?] n	100g/ngà [?]	Tu [?] theo khả năng
N [?] c u [?] ng	1500 ml	2500 ml

Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường

1. Chế độ ăn trong bệnh đái tháo đường

□ Chỉ định : Cho đái tháo typ I và typ II

□ Nguyên tắc

- + Đảm bảo đủ năng lượng để giữ cân nặng bình thường. Đối với người béo cần giảm bớt năng lượng. Giảm NL từng bậc theo mức BMI
- + Không nên dùng đường, mật, mứt, bánh kẹo, chocola
- + Đảm bảo tỷ lệ các thành phần sinh NL
- + Chất xơ: 20 - 40 g / ngày
- + Đủ vitamin, đặc biệt vitamin nhóm B để ngăn ngừa tạo thành xêton.
- + Muối < 6 g / ngày

Chức năng huyết

Chức năng huyết phân tích mức hấp thu của Glucoza máu sau khi ăn thực phẩm nào đó so với bình thường làm chuẩn (100).

Chức năng huyết của một số thực ăn hằng ngày:

Nhóm thực phẩm	Tên thực phẩm	Chức năng huyết	Nhóm thực phẩm	Tên thực phẩm	Chức năng huyết
Bánh mì	Bánh mì trắng	100	Rau củ	Khoai luộc	54
	Bánh mì toàn phần	99		Khoai sọ	58
Lương thực	Gạo trắng	83		Cà rốt	49
	Lúa mạch	31		Củ từ	51
	Yến mạch	85		Khoai nóng	135
	Bột dong	95	đậu	Lạc	19
	Gạo giã rối	72		đậu tưng	18
Quả	Chuối	53		Hạtđậu	49
	Táo	53		đậu nóng	62
	Da hấu	72	Sữa	Sữa gầy	32
	Cam	66		Sữa chua	52
	Xoài	55		Kem	52
	Nho	43	Đường	đường	86
	Mận	24			
	Anh đào	32			

2. Chế độ ăn giảm trọng lượng

2.1. Nguyên tắc:

- Tạo đợc sự thiếu hụt năng lượng bằng cách năng lượng ăn vào ít hơn năng lượng tiêu hao từ 500-1000 Kcal sẽ dẫn tới giảm 10 % trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng
- Hoặc giảm NL từng bậc theo mức BMI
 - + BMI từ 25-29,9 thì NL đưa vào 1500 kcal / ngày
 - + BMI từ 30-34,9 thì NL đưa vào 1200 kcal / ngày
 - + BMI từ 35-39,9 thì NL đưa vào 1000 kcal / ngày
 - + BMI ≥ 40 thì NL đưa vào 800 kcal / ngày

2. Chế độ ăn uống cho bệnh nhân (tiếp theo)

2.2. Thành phần các chất dinh dưỡng

- Protid : 15-25 %
- Lipid : 15 % , nên tăng các axit béo chưa no một hoặc nhiều nối đôi
- Glucid : nên sử dụng G có nhiều chất xơ
- Đủ vitamin và muối khoáng
- Tăng cường rau và quả chín 500g /ngày
- Muối nên < 6 g / ngày nếu có tăng HA thì dùng 2-4 g / ngày
- Không nên dùng đường, mật, mứt, kẹo, bánh kẹo, chocolate

Chế độ ăn giảm Protein

Trong khẩu phần có dới 1g Pr/kg.

- Giảm ít: 0,8 - 0,9 g/kg.
Trứng + sữa + thảo mộc.
- Giảm trung bình: 0,6 - 0,8g/kg.
Ngũ cốc, khoai, rau quả.
- Giảm nhiều: 0,4 - 0,5g/kg.
Cơm + quả + đồng (kempner).
- Bỏ hẳn protid: chế độ ăn Borat - Bull.
Dầu 200 g + đồng 400g.

Chỉ định:

- Khi cơ thể không bài tiết được sản phẩm chuyển hóa Pr : Viêm cầu thận cấp, suy thận mạn (số gam protein = số ure niệu trong 24 giờ x 3)
- Khi Pr trở thành chất độc : Hôn mê gan, hội chứng toan (trong đái đồng)
- Khi Pr không tiêu hóa được do rối loạn tiêu hóa : viêm đại tràng, rối loạn tiêu hoá, suy tụy tạng

Chức năng của lipid

Đặc điểm của lipid:

- Sinh năng lượng : 1g sinh 9,3 kcal
- Có khả năng dự trữ ở các tổ chức cơ thể khi ăn thừa lipid
- Gây co túi mật

Chỉ định:

- Bệnh béo phì
- Bệnh túi mật: Viêm túi mật, sỏi mật do cholesterol lắng đọng
- Xơ mỡ động mạch : Do mảng lipid lắng ở nội mạc mạch máu (cholesterol + este của cholesterol và phospholipid)

*Tắc mật : Nên ăn trứng , kem hoặc dầu thực vật giúp tổng mật ra ngoài

Chế độ ăn hạn chế muối

Bình thường trong CĐA có 10-15 g muối NaCl gồm:

- 40 % muối dùng để nấu nướng
- 40 % có trong các TP chế biến bằng muối
- 20 % có sẵn trong các thức ăn thiên nhiên

Có hai mức hạn chế :

Tương đối: 1,25 - 2,5 g NaCl (0,5-1 g Na)

Tuyệt đối: 0,50 - 1,0 g NaCl (0,1-0,3 g Na)

Chỉ định:

- Suy tim.
- Huyết áp cao.
- Bệnh thận.
- Xơ gan.
- Phụ nữ có thai 3 - 6 tuần lễ cuối.
- Bệnh hạn chế nước.

1.Chế độ ăn hạn chế muối trong ăn (Nacl 1,25 - 2,5 gam)

- Cấm nấu các thức ăn bằng muối
- Không được dùng TẺ bằng muối (kể cả nước mắm)
- Không được dùng cà muối, cá muối và thịt muối
- Được phép dùng : Các TẺ có rất ít muối nh thịt, cá n-
ớc ngọt, gạo khoai, rau quả tươi và thức ăn bản chất
có khá nhiều muối: trứng sữa, cua , nội tạng....

2. Chế độ ăn hạn chế muối tuyt ăn (NaCl 0,5 - 1 gam)

- Cấm dùng các TĂ nh chế độ trên, cấm cả thức ăn thiên nhiên có sẵn muối nh : Sữa , trứng, cua.....

Chế độ ăn chỉ có cơm quả đòng. Không có thịt, cá và sữa bò

Cách hình thành chế độ ăn, uống và chất kích thích

- **Chỉ định:** Trong bệnh loét dạ dày tá tràng, viêm ruột
- **Các TP nên dùng**
 - Sữa, bơ
 - Khoai nghiền bỏ xơ, rau non mềm
 - Trứng
 - Quả thật chín, nước quả
- **Mức độ hạn chế**
 - Hạn chế chặt chẽ : chỉ có sữa bột
 - Hạn chế trung bình: thêm khoai nghiền và trứng
 - Hạn chế ít: thêm thịt mềm thái nhỏ và rau nghiền kĩ

Bệnh nhân nặng thì dùng chế độ hạn chế chặt chẽ, khi đã đỡ có thể dùng chế độ ăn hạn chế vừa hoặc ít

CHẾ ĐỘ ĂN TOAN VÀ KIỀM

CHẾ ĐỘ ĂN HẠN CHẾ PURIN

- Chỉ định: Trong bệnh Gout và bệnh Calci thận
 - Nên ăn các TP có chứa < 50 g purin/ngày (sữa không béo, bánh mì, ngũ cốc, gạo, khoai tây..)

Nuôi dưỡng bệnh nhân đặc biệt

- ☐ Bệnh nhân bỏng
- ☐ BN nuôi dưỡng bằng ống thông
- ☐ Bệnh nhân sau mổ dạ dày

Nuôi dưỡng bệnh nhân đặc biệt

1. CHẾ ĂN CHO BỆNH NHÂN BỤNG

Chỉ định:

- Bụng mức độ nhẹ: Hỗ trợ dinh dưỡng bằng đường tiêu hoá 4 giờ đầu sau nhập viện
- Bụng mức độ trung bình đến nặng: DD bằng đường miệng nên áp dụng càng sớm càng tốt, thông 24-48 giờ sau hồi sức. Có tác giả khuyên nên đặt ống thông dạ dày để nuôi dưỡng

2. Nuôi dưỡng bằng ống thông (chế độ ăn hoàn toàn lỏng)

Chỉ định

- Uốn ván
- Viêm màng não
- Liệt họng vì bạch hầu
- Sau phẫu thuật quan trọng
- Hôn mê

□ Cách truyền

Dùng ống thông dài khoảng 1 m, đường kính 1,2 - 1,5 mm. Bôi Glyxerin hoặc Vaseline rồi cho ống thông vào mũi rất từ từ, khi tới họng thì bảo bệnh nhân nuốt đồng thời ấn ống thông xuống tận dạ dày

□ Cách cho ăn

- Nhỏ giọt liên tục 60 giọt / 1 phút hoặc cho ăn 3 - 4 lần/1 ngày.
- Bơm dung dịch qua ống thông 300-400 ml/lần. Bơm 5-6/lần.
- Sau khi cho ăn cần bơm một ít nước qua ống thông để rửa khỏi tắc ống.
- Cố định ống thông

□ Thời gian và số lượng dùng.

- Cho ăn trong 7-15 ngày, có thể ăn lâu hơn nhng phải thay ống thông 1-2 lần / 1 tháng
- Số lượng : Tùy theo tình trạng bệnh lý và khả năng tiêu hóa, hấp thu của BN mà cho ăn từ 500 - 2000 kcal / ngày
- Chia làm nhiều giai đoạn: Cho ăn tăng dần (bắt đầu 500 Kcal và 30 g protein, sau đó mỗi ngày cho ăn thêm 250 - 500 calo cho đến khi đạt 2000 Kcal)
- Chế biến phải nhuyễn, số lượng ít, thành phần DD cao. Có thể dùng bột mòng khi chế biến

□ Tai biến

- Đau bụng, đầy hơi, ỉa lỏng
- Hội chứng □Dumping□ : Sau khi ăn xong bệnh nhân mệt, nhức đầu, toát mồ hôi run ở bắp cơ do thức ăn thoát khỏi dạ dày quá nhanh, hoặc thức ăn quá đặc hoặc dạ dày bị dẫn
- Bệnh nhân nôn mửa

3. Chỉ định cho bệnh nhân sau mổ dạ dày

☐ Chỉ định:

- ❖ Trong cắt bỏ hoặc nối thông dạ dày-ruột
- ❖ Phẫu thuật chỉnh hình môn vị, cắt bán phần dạ dày

(Đọc SGK)

Nguy^h t^c:

- ❖ Từ 3-5 ngày đầu ăn qua ống thông
- ❖ Sau 5-7 ngày bệnh nhân có thể dung nạp thức ăn đặc
- ❖ Nhu cầu các chất dinh dưỡng: protein 1,5-2g/kg/ngày và 35-40kcal/kg/ngày. Sử dụng một lượng chất xơ và Pectin trong rau và quả giúp giảm hội chứng Dumping. Chú ý bổ sung đủ sắt, B12 và a.folic
- ❖ Đồng chỉ dùng nếu có hạ đường huyết. Tránh các thức ăn ngọt hoặc nước ngọt có ga. Nên tập cho bệnh nhân dùng sữa lượng nhỏ tăng dần, nếu BN không dung nạp do thiếu men Lactose có thể dùng sản phẩm MCT (Medium-Chain-Triglycerid)
- ❖ Chia thành bữa nhỏ 6 lần /ngày

Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện

Bộ Y Tế - 2006

Nguyên tắc xây dựng CĐĂ BV

- Đối với người lớn: Bao gồm 12 CĐĂ
- Đối với trẻ em: Bao gồm 10 CĐĂ, chia theo nhóm tuổi (6 nhóm tuổi).
- Từng CĐĂ trong BV có các kí hiệu riêng

Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện

Bộ Y Tế - 2006

STT	Chế độ ăn trong bệnh viện	Ký hiệu
IV	Chế độ ăn cho bệnh Gút (người lớn)	GU
1	Bệnh gút đơn thuần	GU01-X
2	Bệnh gút có kết hợp với suy thận mạn độ 1, 2	GU02-X
3	Bệnh gút có kết hợp với suy thận mạn độ 3, 4	GU03-X

Những yếu tố quyết định thành công của dinh dưỡng điều trị

1. Theo dõi sự tuân thủ chế độ ăn của bệnh nhân
2. Hiểu biết về thói quen ăn uống của người bệnh
3. Quan sát hành vi ăn uống của người bệnh
4. Chăm sóc những trường hợp đặc biệt
5. Xây dựng thực đơn
6. Giáo dục bệnh nhân